

2026년 제7차 중증(암)질환심의위원회 D+1 결과 리뷰

Leadership Brief | 2026.08.20

항목	내용
회의	2026년 제7차 중증(암)질환심의위원회
회의일	2026년 8월 19일(수)
보고일	2026년 8월 20일(목)
보고 대상	보험약가 · Market Access Leadership
공식 확인	건강보험심사평가원 「2026년 제7차 중증(암)질환심의위원회 심의결과 공개」
핵심 결과	브렌랩주 일부 병용요법 · 보라니고정 · 브루킨사캡슐은 급여기준 설정, 브렌랩주 포말리도마이드 병용요법과 Docetaxel+Trastuzumab은 급여기준 미설정

1. Executive Snapshot

한 줄 결론: 8월 암질심은 사전 공개 신호가 강했던 소세포폐암 · 유방암 재상정 후보가 아니라, 다발골수종 · IDH 변이 저등급 glioma · CLL/SLL · 희귀 침샘도관암 안건을 중심으로 공개됐다. 특히 브렌랩주가 병용요법별로 설정과 미설정이 갈린 점은 앞으로 항암제 급여기준이 제품 단위가 아니라 regimen · 병용 파트너 · 치료 위치 단위로 더 세밀하게 판정된다는 신호다.

3대 leadership implication

Implication	Leadership take-away
제품명이 같아도 regimen별 급여 판단은 갈릴 수 있다	브렌랩주는 보르테조미+덱사메타손 병용요법은 급여기준 설정, 포말리도마이드+덱사메타손 병용요법은 급여기준 미설정으로 공개됐다. 동일 성분 · 동일 질환이라도 병용 파트너, prior therapy, comparator, 재정영향이 다르면 별도 gate로 판단된다.
암질심 안건은 매체 주목도보다 제출 패키지의 완성도에 더 민감하다	임델트라 · 퍼제타주처럼 공개 관심이 컸던 후보는 이번 결과표에 포함되지 않았다. 반대로 브렌랩 · 보라니고 · 브루킨사는 상대적으로 사전 노출이 제한적이었지만 공식 안건으로 공개됐다.
MSD read-through는 병용요법 기준 설계와 eligibility discipline이다	MSD 직접 품목은 포함되지 않았지만, 항암 병용요법의 급여기준 설정 · 미설정 분기, 희귀 소암종의 근거 문턱, biomarker 기반 환자군 제한은 키트루다 병용 · perioperative/adjuvant 전략에 직접적인 payer learning을 제공한다.

2. 공식 심의 결과: compact result table

구분	품목 · 성분	회사	대상/신청 요지	공식 심의 결과
요양급여 결정신청	브렌랩주 — 벨란타맙 마포도틴	글락소스미스클 라인	이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 성인 재발 또는 불응성 다발골수종 환자에서 보르테조미 및 덱사메타손과의 병용요법	급여기준 설정
요양급여 결정신청	브렌랩주 — 벨란타맙 마포도틴	글락소스미스클 라인	레날리도마이드를 포함하여 이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 성인 재발 또는 불응성 다발골수종 환자에서 포말리도마이드 및 덱사메타손과의 병용요법	급여기준 미설정
요양급여 결정신청	보라니고정 — 보라시데넵 시트르산	한국세르비에	생검, 대부분 절제 또는 완전 절제를 포함하는 수술 후 40kg 이상의 12세 이상 소아 및 성인의 IDH1/IDH2 변이 2등급 성상세포종 또는 희돌기교종 치료	급여기준 설정
급여기준 확대	Docetaxel + Trastuzumab	해당 없음	HER2 양성 침샘도관암	급여기준 미설정
급여기준 확대	브루킨사캡슐 — 자누브루티닙	비원메디슨코리아	만 65세 이상 또는 동반질환이 있는 만 65세 미만의 치료 경험이 없는 CLL/SLL 성인 환자 단독요법	급여기준 설정

3. 시장·정책 시사점

첫째, 브렌넨주의 split decision은 항암제 access가 제품 단위에서 regimen 단위로 이동하고 있음을 보여준다. 같은 브렌넨주라도 보르테오미드 병용은 설정, 포말리도마이드 병용은 미설정으로 갈랐다. 이는 HIRA가 하나의 브랜드 value story를 그대로 받아들이기보다, 병용 파트너별 임상 근거, 기존 치료경로, 비교약제, 대상 환자 규모, 예산영향을 각각 평가한다는 뜻이다. 앞으로 다발골수종·림프종·고형암 병용요법은 “제품명+질환명”보다 “line of therapy+combination+prior exposure” 단위로 모니터링해야 한다.

둘째, 보라니고정의 급여기준 설정은 저등급 glioma·분자진단 기반 항암 접근성의 중요한 기준점이다. IDH1/IDH2 변이 2등급 glioma, 수술 후 population, 12세 이상 및 체중 기준이 함께 제시됐다. 이는 희귀 고형암에서 biomarker와 수술 후 상태를 eligibility gate로 정교하게 설정하는 방향을 보여준다. 동일한 희귀·분자표적 영역이라도 환자군 정의가 명확하면 암질심 단계에서 긍정 판단을 받을 수 있다는 점이 중요하다.

셋째, Docetaxel+Trastuzumab 미설정은 희귀 암종의 off-label 또는 regimen 확대가 자동으로 열리지 않음을 의미한다. HER2 양성 침샘도관암은 환자 수가 제한되고 치료 옵션이 적은 영역이지만, 기존 약제 조합의 급여기준 확대라도 근거 수준과 급여기준 문구 설계가 충분하지 않으면 미설정될 수 있다. 희귀 암종에서는 unmet need만이 아니라 국내외 guideline position, 실제 사용 근거, 비교 가능한 치료경로, 투여 범위 제한이 함께 필요하다.

넷째, 브루킨사 급여기준 설정은 혈액암 만성질환형 치료의 line·age·comorbidity 기준 설계를 재확인한다. CLL/SLL 1차 단독요법에서 연령과 동반질환 조건이 함께 제시됐다. 이는 지속 투여가 예상되는 혈액암 치료제에서 eligible population 제한과 치료 위치 명확화가 payer acceptance에 핵심이라는 점을 보여준다.

4. MSD 영향: direct issue는 없지만, read-through는 세 가지

4.1 Keytruda 병용요법: regimen별 분리 평가를 기본 가정으로 뒤야 한다

이번 회의의 가장 직접적인 MSD read-through는 브렌넨주의 split decision이다. 키트루다 병용전략에서도 하나의 성분 또는 하나의 질환군 안에서 병용 파트너, 투여 라인, prior therapy, biomarker, 치료기간이 달라지면 별도 급여기준 판단이 내려질 수 있다. 특히 Padcev+Keytruda처럼 타사 간 병용요법에서는 각 회사의 가격수용, comparator, 재정영향 부담 논리를 제품 단위가 아니라 regimen 단위로 준비해야 한다.

4.2 Perioperative/adjuvant 전략: 환자군 제한과 treatment duration 설명이 더 중요해진다

보라니고정은 수술 후 상태와 분자변이를 함께 정의해 급여기준 설정을 받았다. MSD의 perioperative/adjuvant oncology 전략에서도 수술 전·후 위치, stage, biomarker, 치료기간, 중단 기준을 세밀하게 제시해야 한다. 단순히 “조기암 확대” 또는 “수술 후 보조요법”으로 묶기보다 eligible population을 payer가 재현 가능하게 판단할 수 있도록 제한 문구와 환자 수 가정을 연결해야 한다.

4.3 희귀 암종·소수 환자군: unmet need만으로는 부족하다

Docetaxel+Trastuzumab 미설정은 희귀 암종이라도 근거와 기준 설계가 충분하지 않으면 접근성이 제한될 수 있음을 보여준다. MSD가 희귀 암종 또는 소수 biomarker population에서 접근성 논리를 제시할 때는 외국 guideline, real-world evidence, 국내 환자 수, 기존 치료경로와의 위치를 하나의 evidence chain으로 묶어야 한다.

5. Next watchlist

후보	현재 의미	MSD 관찰 포인트
브렌랩주 후속 절차	병용요법별 설정·미설정이 분리된 다발골수종 ADC 사례	설정된 병용요법의 후속 약평위·협상 진행, 미설정 병용요법의 보완자료 방향 확인
보라니고정	IDH 변이 저등급 glioma의 biomarker 기반 급여기준 설정 사례	희귀 고형암에서 분자진단·수술 후 population 제한이 payer acceptance에 주는 의미 확인
브루킨사캡슐	CLL/SLL 1차 단독요법 급여기준 확대	혈액암 만성질환형 치료에서 연령·동반질환 기준과 장기 투여 BIA logic 확인
Docetaxel+Trastuzumab	HER2 양성 침샘도관암 급여기준 미설정	희귀 암종 regimen 확대의 근거 문턱, 재신청 가능성, guideline/RWE 보완 여부 추적
임델트라·퍼제타주·티루캡	이번 차수 결과표 미포함 후보	다음 암질심 전까지 실제 보완자료 제출·재신청·공식 안전 신호가 확인되는지 재점검
9차 약평위 후보	2026년 9월 3일 예정 차수	사이람자·엘라히어·버제니오 등 암질심 통과 후 약평위 전환 후보의 경평소위·결정신청 신호 확인

6. Leadership actions

1. Regimen-level tracker 강화: 항암제 watchlist를 품목명 중심에서 regimen·병용 파트너·line of therapy 단위로 확장한다. 브렌랩주처럼 같은 품목 내 split decision이 발생할 수 있음을 표준 모니터링 항목으로 반영한다.
2. 사전 신호 gate 재정의: 환자단체·매체 주목도가 큰 후보라도 회사 재신청, 보완자료, 구체 차수 언급, 공식 결과에서의 재논의 문구 중 일부가 확인되기 전까지는 high-confidence agenda로 올리지 않는다.
3. MSD 병용요법 dossier checklist 보강: 키트루다 병용요법에서는 병용 파트너별 임상 근거, comparator, 가격·재정영향 부담, eligibility, treatment duration을 별도 sheet로 관리한다.
4. 다음 차수 official-source 확인 유지: 9차 약평위 전에는 암질심 통과 후 전환 후보의 경평소위/결정신청 신호와 비oncology·희귀질환 단일 품목 가능성을 동시에 확인한다.

7. 출처 및 해석 범위

본 brief의 공식 사실은 건강보험심사평가원이 공개한 「2026년 제7차 중증(암)질환심의위원회 심의결과 공개」의 회의명, 회의일, 품목명, 성분·요법, 회사명, 대상 질환·신청 요지, 심의 결과 문구에 근거한다. 시장·정책 시사점과 MSD 영향은 해당 공식 결과를 바탕으로 한 Market Access 해석이며, 실제 급여 여부·약가·시행일·세부 급여기준은 약평위, 약가협상, 건강보험정책심의위원회, 보건복지부 고시 이후 확정된다.

이 문서는 공개 결과를 leadership 의사결정용으로 압축한 것이며, 비공개 환급률, 회사별 내부가격, 최종 약가 또는 특정 품목의 등재일을 추정하지 않는다. 내부 운영·검증 메타는 본 leadership brief가 아니라 별도 audit 및 운영 노트에서 관리한다.